หมวด 4	Governance Excellence
แผนงานที่ 10	**การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ**
โครงการ	**โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล (RLU hospital Plus)**
ระดับการแสดงผล	**ระดับจังหวัด**
ชื่อตัวชี้วัด 40	**ร้อยละความสำเร็จของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาโรงพยาบาลที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (RLU hospital Plus) ตามที่กำหนด*** **40.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1c ซ้ำภายใน 90 วัน** **40.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1c อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง** **40.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ LDL ซ้ำภายใน 90 วัน** **40.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ LDL อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง** **40.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจ Creatinine อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง** **40.6 ร้อยละของผู้มารับบริการได้รับการตรวจ Cholesterol ซ้ำภายใน 90 วัน** **40.7 ร้อยละของผู้มารับบริการได้รับการตรวจ Triglycerides ซ้ำภายใน 90 วัน** **40.8 ร้อยละของการพัฒนาโรงพยาบาลที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (RLU hospital Plus) ตามเกณฑ์ที่กำหนด* ในรายการตรวจ HbA1c, LDL, Cholesterol, Triglycerides, BUN, Cr, TSH, FT3, FT4, T3 และ Hb typing** และรายการตรวจอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลได้วิเคราะห์ข้อมูล
หน่วยวัด	**ระดับ**
เกณฑ์เป้าหมาย	**ระดับ 5**
คำนิยาม	**1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU)** หมายถึง การสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีประสิทธิภาพและถูกต้อง โดยเลือกใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสมในการคัดกรอง การวินิจฉัย การติดตามผลการรักษาและพยากรณ์โรค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ **2. ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล (RLU region public health)** หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่มีโรงพยาบาลที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล (RLU hospital Plus) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ **3. กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน** หมายถึง ประชากรที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน และได้รับตรวจติดตามภาวะโรคเบาหวานด้วยการตรวจ HbA1c, LDL และ Creatinine ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานควรได้รับการตรวจ HbA1c และ LDL ซ้ำภายใน 90 วัน ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นการลดการสั่งตรวจซ้ำที่เกินความจำเป็น ในอีกทางหนึ่งคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานควรได้รับการตรวจ HbA1c, LDL และ Creatinine อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มากกว่าร้อยละ 70 เพื่อเป็นการติดตามการตรวจที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไป และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ป่วย **4. ผู้มารับบริการ** หมายถึง ผู้มารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจ Total Cholesterol และ Triglycerides **5. กลุ่มผู้ป่วยโรคไต CKD (BUN, Cr)** **6. กลุ่มผู้ป่วยโรคไทรอยด์ (TSH, FT3, FT4, T3)** **7. กลุ่มผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมีย (Hb typing)**
วัตถุประสงค์	1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล มีประสิทธิภาพและถูกต้องมีความเหมาะสม คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด

	2. เพื่อส่งเสริมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไต โรคไทรอยด์ โรคทาลัสซีเมีย ทั้งด้าน Overutilization และ Underutilization ในรายการตรวจ **HbA1c, LDL, Cholesterol, Triglycerides, BUN, Cr, TSH, FT3, FT4, T3 และ Hb typing** ด้าน Overutilization และรายการตรวจอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลได้วิเคราะห์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 18 แห่ง
ระยะเวลาประเมินผล	ประเมินผล 2 รอบ (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) และคำนวณตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน	**เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จ**

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√
3			√	√	√
4				√	√
5					√

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

1) **การประเมินผลการดำเนินงานรอบ ที่ 1/2569 (รอบ 6 เดือน)**
   - **ผ่านคะแนนระดับ 4**
2) **การประเมินผลการดำเนินงานรอบ ที่ 2/2569 (รอบ 12 เดือน)**
   - **ผ่านคะแนนระดับ 5**

ระดับคะแนน	**รายละเอียดของกิจกรรม**
1	- แต่งตั้งคณะกรรมการ RLU โดยมีองค์ประกอบแบบสหวิชาชีพ (แพทย์/พยาบาล DM/ IT/ Lab/ อื่นๆ) ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้บริหารสูงสุด - มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักหรือผู้ประสานงานด้าน RLU ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ ผู้บริหารสูงสุด - มีรายงานการประชุม/มติ/การนำไปปฏิบัติ
2	- จัดทำนโยบายประกาศเจตนารมณ์ มุ่งสู่ RLU Hospital ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้บริหารสูงสุด - หลักฐานการสื่อสาร ที่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
3	- มีหลักฐานการประชุมและมติ รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกโรค หรือภาวะ หรือรายการตรวจที่เป็นปัญหาในการสั่งตรวจ (overutilization และ/หรือ underutilization) - มีบัญชีรายการโรค หรือภาวะ หรือรายการตรวจที่เป็นปัญหา (overutilization และ/หรือ underutilization)
4	- กำหนดมาตรการหรือแนวทางข้อปฏิบัติเพื่อลด Overutilization และ Underutilization แสดงมาตรการ หรือประกาศ หรือแนวทางของโรงพยาบาลที่กำหนดในการปฏิบัติงาน - กำหนดมาตรการ โดยการใช้ระบบ IT โดยมีหลักฐานแสดงการใช้ระบบ IT ในการกำหนดมาตรการ เช่น Pop up แจ้งเตือนการส่งตรวจซ้ำ - ประกาศมาตรการ โดยหลักฐานแสดงการสื่อสารไปที่สหวิชาชีพ

		- กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน HbA1c, LDL, Cholesterol, Triglycerides, BUN, Cr, TSH, FT3, FT4, T3 และ Hb typing โดยมีหลักฐานการกำหนดเป็นตัวชี้วัด RLU ของโรงพยาบาลที่ระบุเป้าหมาย วัดผลได้ ที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้บริหารสูงสุด ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร - มีหลักฐานการประเมินผลตัวชี้วัด RLU และแสดงผลการติดตามตัวชี้วัดโดยใช้ระบบ IT
	5	สรุปผลการดำเนินงาน (After Action Review, AAR) และเสนอแนวทางการพัฒนา (Rational Lab Use)

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดย่อย

40.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1C ซ้ำภายใน 90 วัน

ระดับ	1	2	3	4	5
ร้อยละ	≤25	≤20	≤15	≤10	<5

สูตรการคำนวณตัวชี้วัดย่อย = A/B * 100

A : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C ซ้ำภายใน 90 วัน

B : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c ทั้งหมด

40.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1C อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระดับ	1	2	3	4	5
ร้อยละ	>50	>55	>60	>65	>70

สูตรการคำนวณตัวชี้วัดย่อย = A/B * 100

A : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C

B : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานทั้งหมด

40.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ LDL ซ้ำภายใน 90 วัน

ระดับ	1	2	3	4	5
ร้อยละ	≤25	≤20	≤15	≤10	<5

สูตรการคำนวณตัวชี้วัดย่อย = A/B * 100

A : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ LDL ซ้ำภายใน 90 วัน

B : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ LDL ทั้งหมด

40.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ LDL อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระดับ	1	2	3	4	5
ร้อยละ	>50	>55	>60	>65	>70

สูตรการคำนวณตัวชี้วัดย่อย = A/B * 100

A : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ LDL

B : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานทั้งหมด

40.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ Creatinine อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระดับ	1	2	3	4	5
ร้อยละ	>50	>55	>60	>65	>70

สูตรการคำนวณตัวชี้วัดย่อย = A/B * 100

A : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Creatinine

B : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานทั้งหมด

40.6 ร้อยละของผู้มารับบริการได้รับการตรวจ Cholesterol ซ้ำภายใน 90 วัน

ระดับ	1	2	3	4	5
ร้อยละ	≤25	≤20	≤15	≤10	<5

สูตรการคำนวณตัวชี้วัดย่อย = A/B * 100

A : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันที่ได้รับการตรวจ Cholesterol ซ้ำภายใน 90 วัน

B : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันที่ได้รับการตรวจ Cholesterol ทั้งหมด

40.7 ร้อยละของผู้มารับบริการได้รับการตรวจ Triglycerides ซ้ำภายใน 90 วัน

ระดับ	1	2	3	4	5
ร้อยละ	≤25	≤20	≤15	≤10	<5

สูตรการคำนวณตัวชี้วัดย่อย = A/B * 100

A : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันที่ได้รับการตรวจ Triglycerides ซ้ำภายใน 90 วัน

B : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันที่ได้รับการตรวจ Triglycerides ทั้งหมด

40.8 ร้อยละของการพัฒนาโรงพยาบาลที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (RLU hospital Plus) ตามเกณฑ์ที่กำหนด* ในรายการตรวจ HbA1c, LDL, Cholesterol, Triglycerides, BUN, Cr, TSH, FT3, FT4, T3 และ Hb typing และรายการตรวจอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลได้วิเคราะห์

ระดับ	1	2	3	4	5
ขั้นตอน	1	2	3	4	5

<u>หมายเหตุ</u>

ข้อ 40.1 – 40.7 ข้อมูล HDC ของโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 40.8 รพ.ทุกแห่ง รายงาน RLU hospital ใน E-Report บน <u>www.rluthailand.com</u>

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2566	2567	2568
40.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1C ซ้ำภายใน 90 วัน **เป้าหมาย <5%**	ร้อยละ	N/A	N/A	รอบ 1 = 3.63 % รอบ 2 = 6.21 %
40.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1C อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง **เป้าหมาย >70%**	ร้อยละ	N/A	N/A	รอบ1 = 64.82 % รอบ2 = 78.62 %
40.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ LDL ซ้ำภายใน 90 วัน **เป้าหมาย <5%**	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
40.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ LDL อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง **เป้าหมาย >70%**	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
40.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ Creatinine อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง **เป้าหมาย >70%**	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A

	40.6 ร้อยละของผู้มารับบริการได้รับการตรวจ Cholesterol ซ้ำภายใน 90 วัน **เป้าหมาย <5%**	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
	40.7 ร้อยละของผู้มารับบริการได้รับการตรวจ Triglycerides ซ้ำภายใน 90 วัน **เป้าหมาย <5%**	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
	40.8 ร้อยละของการพัฒนาโรงพยาบาลที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (RLU hospital plus) ตามเกณฑ์ที่กำหนด* ในรายการตรวจ HbA1c, LDL, Cholesterol, Triglycerides, BUN, Cr, TSH, FT3, FT4, T3 และ Hb typing **เป้าหมาย 100% จำนวน 18 รพ.**	ระดับ	N/A	N/A	รอบ 1= 18 รพ. รอบ 2 =18 รพ. 100%

เอกสารสนับสนุนการดำเนินงาน	แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Lab Use, RLU) โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง จำนวน 18 รพ. ในจังหวัดกาฬสินธุ์
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ระบบการรายงาน RLU hospital ใน E-Report บน www.rluthailand.com ข้อมูล HDC ของโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 18 แห่ง
หน่วยปฏิบัติ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาล 18 แห่ง ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับการวัด	จังหวัด/ อำเภอ
ผู้กำกับตัวชี้วัด	นายแพทย์ประธาน ศรีจุลฮาด ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมทั่วไป) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์มือถือ : 087 213 6907 สถานที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางถมญาณี โชติการณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4301 9760 ต่อ 103 โทรศัพท์มือถือ : 081 592 4299 สถานที่ทำงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ผู้ประสานการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	นางสาวปวีณ์นุท ภูนาสอน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4301 9760 ต่อ ๑๐๓ โทรศัพท์มือถือ : 082 304 6496 E-mail : meawkeaw12@gmail.com สถานที่ทำงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน	นายกอบเดช เพชรตะกั่ว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4312 6920 ต่อ 114 โทรศัพท์มือถือ : 094 391 9694 E-mail : nakhulab28017@hotmail.com สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนาคู

เกณฑ์ที่กำหนดการเป็น RLU hospital

กิจกรรม	หลักฐาน
<u>บันไดขั้นที่ ๑ กรรมการ RLU</u>	
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ RLU และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก (อาจเรียกว่า Mr. RLU หรือ RLU coordinator ฯลฯ)	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการRLU ที่เป็นสหสาขา ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้บริหารสูงสุด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักหรือผู้ประสานงานด้าน RLU ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ ผู้บริหารสูงสุด ๓. มีรายงานการประชุม / มติ / การนำไปปฏิบัติ
๑.๒ จัดทำประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่ RLU hospital ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล	๑. มีประกาศเจตนารมณ์หรือนโยบาย RLU ที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้บริหารสูงสุดลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. หลักฐานการสื่อสาร ที่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
<u>บันไดขั้นที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูล</u>	
๒.๑ วิเคราะห์ข้อมูล **และ**คัดเลือก โรค หรือภาวะ หรือรายการตรวจที่เป็นปัญหาในการสั่งตรวจ (overutilization และ/หรือ underutilization)	๑. มีหลักฐานการประชุมและมติ รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกโรค หรือภาวะ หรือรายการตรวจที่เป็นปัญหาในการสั่งตรวจ (overutilization และ/หรือ underutilization) ๒. มีบัญชีรายการโรค หรือภาวะ หรือรายการตรวจที่เป็นปัญหา (overutilization และ/หรือ underutilization)
<u>บันไดขั้นที่ ๓ กำหนดมาตรการเพื่อลด</u> overutilization และ/หรือ underutilization	
๓.๑กำหนดมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อลด overutilization และ/หรือ underutilization	๑. มีหลักฐานแสดงมาตรการ หรือประกาศ หรือแนวทางของโรงพยาบาลที่กำหนดในการปฏิบัติงาน
๓.๒กำหนดมาตรการ โดยการใช้ระบบ IT*	๑. มีหลักฐานแสดงการใช้ระบบ IT ในการกำหนดมาตรการ เช่น Pop up แจ้งเตือนการส่งตรวจซ้ำ
๓.๓ประกาศมาตรการ*	๑. มีหลักฐานแสดงการสื่อสารไปที่สหวิชาชีพ
<u>บันไดขั้นที่ ๔ การประเมินผล</u>	
๔.๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด และการประเมินผล RLU (ตัวชี้วัดด้าน overutilization และ/หรือ underutilization)	๑. มีหลักฐานการกำหนดเป็นตัวชี้วัด RLU ของโรงพยาบาลที่ระบุเป้าหมาย วัดผลได้ ที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้บริหารสูงสุด ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. มีหลักฐานการประเมินผลตัวชี้วัด RLU
๔.๒มีการติดตามตัวชี้วัด โดยใช้ระบบ IT*	๑. แสดงผลการติดตามตัวชี้วัดโดยใช้ระบบ IT

หมายเหตุ ควรเพิ่มโรค ภาวะ หรือรายการตรวจที่เป็นปัญหา overutilization และ/หรือ underutilization ทุกปี

*** โรงพยาบาลที่ถูกประเมินให้เป็น RLU hospital Plus**